

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071632-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCIA NORBERTO SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA FORNECIMENTO DA “CPAP, INTERFACE (MÁSCARA) NASAL OU ORO NASAL, ALÉM DE FILTROS ADICIONAIS PARA O CPAP (O FILTRO DEVE SER TROCADO A CADA 3 MESES”. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5071632-89.2024.4.02.5101

510014573750 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071632-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCIA NORBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, na qual a União, objetiva atribuir efeito suspensivo a decisão proferida nos autos originários de nº 5071632-89.2024.4.02.5101 (Evento 42) pelo juízo do 1º Juizado Especial Federal de Niterói que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, com vistas ao fornecimento do insumo “CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP (o filtro deve ser trocado a cada 3 meses”.

A parte autora apresentou contrarrazões (evento 10).

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

“DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta em face do Juízo Federal do 1º Juizado Especial Federal de Niterói, em razão da decisão proferida, in verbis:

“DESPACHO/DECISÃO

A parte autora acostou aos autos a prescrição médica atualizada e três orçamentos de estabelecimentos distintos, relativos ao insumo objeto da presente demanda, qual seja, o dispositivo CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP (EVENTO 138).

Foram intimados os réus para manifestação quanto ao não fornecimento do insumo, inclusive com bloqueio de verbas do réu ESTADO DO RIO DE JANEIRO por meio do SISBAJUS - EVENTOS 53, 67, 85, 108, 122, 134 e 137 - no entanto, observo que decorridos os prazos in albis.

Assim, defiro o pedido de penhora on line, para determinar a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com supedâneo no art. 854 do CPC, em rateio, em desfavor dos réus, ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE NITERÓI, com o bloqueio da quantia de R\$1.598,63, PARA CADA RÉU, referente ao orçamento de menor valor acostado ao EVENTO 138, ANEXO 2, FL. 4.

Sendo encontrados valores, determino desde já a sua transferência via SISBAJUD para uma conta à disposição deste 1º juizado Especial Federal de Niterói na Caixa Econômica Federal, agência nº 0174.

Sem prejuízo da medida acima e diante da impossibilidade de bloqueio de verbas da União através da penhora on line, determino a expedição de RPV no valor total de R\$ 1.598,63, para aquisição do medicamento objeto desta ação, intimando-se em seguida as partes.

Efetuada o bloqueio e a transferência bancária com relação ao Estado do Rio de Janeiro e ao Município de Niterói, intime-se o autor sobre a expedição de mandado de pagamento em seu favor.

Por fim, visando o princípio da celeridade, voltem conclusos para sentença, sem prejuízo da obrigação da autora de apresentar aos autos nota fiscal discriminada com os itens adquiridos, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal."

Aduziu que o magistrado do Juizado Especial Federal determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV antes do trânsito em julgado e que a expedição deliberada de RPV antes do trânsito em julgado representa flagrante violação à ordem legal e constitucional de pagamentos. Requereu a concessão da segurança para cassar o ato impugnado e assim reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado.

É o breve relatório.

Observa-se que a determinação de expedição de RPV em face da União adveio do descumprimento da decisão proferida no evento 9 do processo originário nº 5008965-98.2023.4.02.5102, *ipsis litteris*:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação movida contra a UNIÃO FEDERAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICÍPIO DE MARICÁ, com pedido liminar, no qual a parte Autora portadora de Apneia obstrutiva do Sono de severa intensidade (SAOS), ronco, hipertensão arterial sistêmica, respiração oral e rinite crônica, requer a tutela de evidência para que os réus forneçam o dispositivo CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP, que contenham as especificações descritas no laudo anexado à peça inicial, uma vez que não possui recursos financeiros para adquirir o equipamento de alto custo.

O parecer do NAT (Evento 7) informa que o tratamento com a utilização do dispositivo pleiteado - CPAP, é a forma mais eficiente de tratar a patologia que sofre a parte autora, na medida em que os pacientes portadores de distúrbios mais graves aderem facilmente a essa forma de tratamento. A SAOS, acima mencionada, pode inclusive resultar em doença cardiovascular, o que inclui a hipertensão arterial sistêmica, doença que já acomete o autor, conforme documentação médica juntada à lide, podendo culminar em morte súbita.

Acrescenta ainda o parecerista que a CONITEC escolhe o CPAP para tratamento de distúrbios respiratórios, em pacientes com quadro de carência respiratória em ambientes de UTI, pronto atendimento, atendimento domiciliar e pacientes com apneia obstrutiva do sono com respiração espontânea.

Acrescenta-se, ainda, que o **NatJus esclarece no sentido de que o equipamento mencionado e o insumo máscara nasal, conforme prescrito, não apenas estão indicados para o tratamento do autor, como são imprescindíveis e eficazes para o manejo da patologia da parte Autora - Ev. 1.Anexo2. Pág.17.**

Porém, o equipamento e insumos pleiteados não estão padronizados em nenhuma lista para dispensação via SUS, bem como não há alternativa terapêutica padronizada no SUS que substitua o equipamento CPAP e o insumo nasal para apneia do sono, segundo esclarece o parecerista.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, que deve prestá-la integralmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, possibilitando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Desta forma, verifica-se que não há direito absoluto a todo e qualquer tratamento, mas sim apenas àqueles que podem ser implementados por meio de políticas públicas, com acesso universal e igualitário por todos os cidadãos.

Assim, "da leitura do artigo 196 da Constituição, conclui-se não ser exigível que o Estado forneça todo e qualquer tratamento médico ou medicamento, mas apenas aqueles ofertados no bojo de políticas públicas previamente elaboradas pelo Poder Executivo, a quem compete,

prioritariamente, o planejamento e a execução de ações preventivas e curativas na área da saúde, de acordo com as limitações orçamentárias existentes" (cf. TRF2, 7ª Turma Esp., proc. nº 2007.51.01.0221947, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. em 08.07.2015).

Nas palavras do i. Min. Gilmar Mendes, "não há um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde [...]. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada". (STF, STA nº 175, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 17.03.2010).

Portanto, nas ações que busquem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, deve o Poder Judiciário agir com cautela, de modo a não interferir na seara administrativa e, com isso, piorar o quadro já calamitoso em que se encontra a saúde pública no Brasil.

Por outro lado, não se pode ignorar a precária situação em que se encontram os cidadãos que buscam o Judiciário para obter tratamento condigno com suas moléstias, sendo tarefa tormentosa aferir se, no caso concreto, a parte Autora faz jus ao tratamento pleiteado.

Nesse diapasão, no bojo da supramencionada Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, o Min. Gilmar Mendes determinou a realização de Audiência Pública, na qual foram ouvidos diversos representantes dos setores envolvidos, de modo a buscar uma racionalização para as inúmeras demandas envolvendo as mais diversas prestações de saúde, tais como: fornecimento de medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses; criação de vagas de UTIs e leitos hospitalares; contratação de servidores de saúde; realização de cirurgias e exames; custeio de tratamento fora do domicílio, inclusive no exterior, entre outros.

Após a referida audiência, ao proferir decisão de mérito na supracitada STA nº 175, o Min. Gilmar Mendes discorreu acerca dos diversos dados e critérios que devem orientar as decisões judiciais, de modo que não haja indevida interferência nas políticas públicas a cargo do Poder Executivo e nem prejuízo ao direito à saúde.

Registre-se que é assente o entendimento jurisprudencial acerca da solidariedade entre os entes federativos no que tange às demandas de saúde (cf. TRF2, 5ª Turma Esp., AI nº 0002342-98.2014.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Marcus Abraham, Dje de 26.05.2014).

O primeiro dado a ser considerado é a existência de tratamento fornecido pelo SUS para a moléstia apresentada pela parte Autora; e sendo este não mais eficaz diante de um quadro avançado da doença, como é o caso dos autos, não há que se falar em ingerência indevida pelo Poder Judiciário nas políticas públicas, pois se tratará apenas de determinar que a Administração cumpra obrigação por ela mesma imposta.

Verifica-se que o tratamento pleiteado, diante da informação do próprio NAT de que não é fornecido pelo Poder Público e que sequer identifica outro equipamento/insumo que configure alternativa terapêutica ao que foi prescrito, deve ser assegurado à parte Autora pelo Poder Público.

Porém, deve-se considerar que a garantia constitucional de inviolabilidade do direito à vida se materializa, em todo o território nacional, por meio de ações concretas implementadas pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, que estabelece políticas efetivas no âmbito da saúde pública, por suas Secretarias Estaduais e Municipais.

Diante dos documentos anexados aos autos, verifica-se que inexistente dúvida acerca do delicado estado de saúde da parte Autora e que a mesma necessita dos equipamentos/insumos pleiteados para poder iniciar seu tratamento, haja vista as consequências no quadro clínico do autor que envolvem os distúrbios do sono e as demais patologias decorrentes, inclusive, cardiovascular com risco de morte súbita. O Autor, assim, precisa deste tratamento para qualidade de vida, saúde e redução de risco de morte por doença cardiovascular.

Dessa forma, o Estado, o que abarca todos os entes federativos, não pode se furtar às diretrizes ditadas em sede constitucional e legal, inviabilizando o tratamento do autor, ainda mais por se encontrar em jogo o legítimo direito à vida, possuindo o demandante, portanto, o direito concreto de exigir dos Réus o que necessita para viver.

Sendo assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam, o *fumus boni iuris* decorrente do direito constitucional à saúde e o *periculum in mora*, em razão de que há risco de agravamento do quadro clínico, o que pode culminar em risco de morte, com a devida urgência, nos termos do art. 300 e 536 caput e § 1º, todos do CPC.

Em observância ao que foi decidido pelo STF, no Tema 793, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, caberá à UF, haja vista que não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da enfermidade do autor, sendo responsabilidade do Ministério da Saúde a criação de tais protocolos para oferecimento na Rede Pública de Saúde, sem prejuízo de posterior ressarcimento das despesas pelos outros entes públicos envolvidos (União Federal e Município de Niterói) ou redirecionamento pelo descumprimento.

*Diante do exposto, **DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** para DETERMINAR que a União forneça o dispositivo CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP, que contenha as especificações descritas no laudo anexado à peça inicial, na forma prescrita no documento acostado ao Ev. 1.anexo2.pág.17, na quantidade necessária à preservação da saúde, **no prazo de 15 (quinze) dias**, sob pena de multa diária e/ou penhora de verbas públicas.*

Citem-se e intime-se a União, com urgência, para cumprimento da presente decisão.

Caso não seja fornecido pela UF ou nenhum dos demais, por meio de redirecionamento, deverá ser observada, no futuro processamento do feito, a necessidade de a parte Autora apresentar outros três orçamentos atualizados do equipamento e insumo pleiteado."

Sobre o tema debatido, propriamente dito, destaca-se a tese fixada, em sede de recurso repetitivo, que permite a efetivação de sequestro de recursos, via bloqueio de recursos, em hipótese de desídia do ente público, no cumprimento de demanda de direito à saúde:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ."

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Transcreve-se, ainda, trecho do voto do Relator:

"4. Dessa forma, é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida da parte demandante.

5. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima.

6. Frise-se, ainda que, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.09.2008).

7. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde da demandante com o fornecimento dos medicamentos adequados, em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo."

No caso, o órgão julgador verificou que não houve o cumprimento da decisão pela União, determinando a intimação da mesma para manifestação sobre as providências pertinentes.

Até a presente data não há informação sobre o cumprimento de tutela pelos réus.

Seria tudo muito mais fácil, é verdade, que a União fornecesse um número de conta bancária para bloqueio, como faz o Estado do Rio de Janeiro e o Município, quando se faz necessário, para uso do sistema BACENJUD, mas isso não é possível, quando se trata da União, cuja conta não é bloqueável, como determinam os enunciados das Jornadas de Saúde, ao estabelecer as prioridades de forma de execução.

Se isso fosse feito, não seria expedido RPV.

Sendo assim, por ora, pelos fundamentos acima, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão que determinou a expedição de RPV.

Intime-se a parte autora para apresentação de contrarrazões.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Após, à conclusão para voto."

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante, que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.

5071632-89.2024.4.02.5101

510014573749 .V4